ODO-LD05 | Edición 03 | Revisión: 09/10/2026

Desinfección de unidad entre pacientes y al cierre

Objetivo

Establecer una secuencia verificable para desinfección de unidad entre pacientes y al cierre, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

Alcance y responsabilidades

Aplicación en odontologia ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Confirmar aplicabilidad al prestador y sede antes de adoptar.

Términos de uso

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

Entre pacientes

Retirar barreras, residuos y accesorios con guantes; enviar reutilizables a reprocesamiento. Limpiar y desinfectar mandos, lámpara, bandeja, silla, apoyos y otras superficies tocadas o salpicadas conforme a manual; no pulverizar dentro de conexiones o electrónica.

Accesorios

Esterilizar piezas de mano y accesorios reutilizables compatibles entre pacientes. Cambiar puntas/jeringas/eyectores de único uso; boquillas reutilizables siguen instrucciones validadas. No considerar una toallita equivalente a esterilización.

Reposición

Verificar superficie seca cuando corresponde y colocar barreras nuevas sin contaminación. Preparar instrumental liberado y verificar paquete delante del proceso clínico. No colocar material limpio en bandeja aún contaminada.

Al cierre

Limpiar succión, escupidera y filtros según instrucciones; tratar líneas de agua y drenar sistemas solo como autoriza fabricante. Limpiar pisos y mobiliario, segregar residuos y dejar productos rotulados. Registrar anomalías y restringir unidad insegura.

Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones

Preparación y selección

Identificar superficie/dispositivo, material, suciedad y nivel de riesgo. Leer etiqueta, ficha técnica y de seguridad; verificar uso autorizado, compatibilidad, concentración, vida útil y tiempo de contacto. Definir EPP, ventilación y elementos diferenciados por zona antes de iniciar.

Ejecución verificable

Delimitar área, retirar suciedad y residuos, limpiar y aplicar desinfectante compatible. Mantener contacto indicado, sin secado anticipado ni mezclas improvisadas. Para agua, succión, impresiones o residuos aplicar instrucciones particulares descritas en este documento; limpiar no equivale a esterilizar.

Contención de fallas

Ante producto no identificado, dilución incorrecta, derrame o superficie incompatible, detener y aislar área/material. Evaluar exposición y atención ocupacional cuando pertinente. Repetir proceso solo después de corregir causa y comprobar que material no quedó dañado o con residuo peligroso.

Cierre de actividad

Registrar área/equipo, producto/lote, preparación, tiempo real, resultado y responsable; liberar espacio cuando condición segura esté verificada. Los controles de agua requieren resultados y acciones, los residuos requieren entrega y soporte; no sustituirlos por una lista diaria genérica.

Supervisión y mejora

Observar técnica y oportunidad entre pacientes, disponibilidad de EPP/productos y correspondencia con cronograma. Revisar desviaciones recurrentes, calidad del agua, contaminación ambiental y capacidad de personal; ajustar frecuencia por riesgo y conservar evidencia de capacitación.

Frecuencia y puntos de control

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

Registros relacionados

Usar los formatos individuales vinculados al código ODO-LD05 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

Verificación, fundamento y adopción

Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas × 100. Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609

Fuentes técnicas particulares

Consultar versión íntegra y vigente, población y metodología; adaptar con trazabilidad. Una referencia técnica orienta práctica y no es legislación colombiana.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2183-de-2004.pdf ;
https://www.cdc.gov/dental-infection-control/hcp/summary/sterilization-disinfection.html

Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

Adopción y actualización

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.